

Fluxograma - Acesso ao Procedimento de Esterilização Cirúrgica Eletiva - Laqueadura Tubária

Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF)

Usuária com interesse em Esterilização Cirúrgica Eletiva- Laqueadura Tubária

Início

Recepção agenda Consulta ou Grupo de Planejamento Reprodutivo com profissional de saúde

Profissional de saúde realiza Consulta ou Grupo de Planejamento Reprodutivo

NÃO

Oferecer outros métodos contraceptivos

Fim

SIM

Usuária permanece com interesse em realizar Laqueadura Tubária e elegível para os critérios legais ?

Disponibiliza a relação dos documentos necessários para acessar esse processo

- Documento oficial com foto;
- Cartão Nacional do SUS;
- Comprovante de Residência;
- Certidão de Nascimento dos Filhos;
- Declaração de participação no Grupo Planejamento Reprodutivo;
- Declaração do médico da UBSF;
- Termo de Consentimento Livre Esclarecido.

Encaminha para Consulta Médica

Médico declara usuária apta e orienta a comparecer com profissional de saúde após 60 dias

Usuária retorna com profissional de saúde após 60 dias para confirmar a decisão e entregar documentação

NÃO

Profissional de saúde confere a documentação, realiza a cópia, envia e-mail para Central de Regulação (laqueadura.joinville@gmail.com) e solicita procedimento via SIG-SaudeTech com o código nº 99001081

SIM

Usuária Gestante?

Profissional de saúde orienta apresentar a documentação na maternidade no dia do parto

Fim

Central de Regulação Municipal

Médico Regulador avalia, prioriza o agendamento da consulta com Cirurgião Ginecológico e autoriza procedimento

Profissional Administrativo ao receber AIH insere no SISREG

Central de Regulação Estadual (SISREG)

Médico Regulador:
- Autoriza o procedimento;
- Insere em mapa cirúrgico;
- Comunica Regulação Municipal e Hospital Executante

Hospital Executante

Cirurgião Ginecológico solicita exames e orienta cuidados pré-operatórios à usuária

Cirurgião Ginecológico preenche e encaminha Autorização de Internação Hospitalar (AIH) para Regulação Municipal

Hospital Executante agenda o procedimento e comunica usuária a data do agendamento

Usuária comparece na data agendada com a documentação exigida e realiza o procedimento

Usuária recebe orientações no pós-operatório imediato

Fim

Crítérios Legais (Lei nº 14.443, de 02/09/2022) para Laqueadura Tubária:
- Homens e Mulheres com capacidade civil plena, maiores de 21 anos de idade;
- Homens e Mulheres com capacidade civil plena, com pelo menos 02 (dois) filhos;
- Observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, inclusive aconselhamento por equipe multidisciplinar, com vistas a desencorajar a esterilização precoce;
- Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro conceito, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

Caso haja intercorrência o Enfermeiro ou Médico da UBSF podem encaminhar para retorno no Hospital

Anexo 09 – Termo de Consentimento Livre Informado – Esterilização Cirúrgica Eletiva Feminina – Laqueadura Tubária para gestantes.

Eu, _____, _____ anos, portadora do RG _____, órgão Emissor _____, CPF _____, e cartão nacional do SUS _____, venho por meio deste Termo de Consentimento Livre Informado, manifestar meu desejo de ser submetida e autorizar a realização de Esterilização Cirúrgica Voluntária e Eletiva Feminina: LAQUEADURA TUBÁRIA.

Também sei que entre a manifestação de minha vontade (por meio deste documento) e o procedimento cirúrgico deverão se passar, ao menos, 60 dias, conforme a Lei nº 9.263/1996 alterada pela Lei nº 14.443, de 02 de setembro de 2022 e que, de acordo com a mesma lei, desde que observado esse prazo mínimo, é permitida a laqueadura durante o período do parto.

Antes da operação, foi-me informado que:

1. A intervenção de laqueadura tubária consiste na interrupção da continuidade das tubas uterinas ou retirada das mesmas (salpingectomia), com o objetivo de impedir gravidez, e que para realização deste procedimento existem várias formas de cirurgia:

- **Laparoscópica** – cirurgia realizada por meio de 3 ou 4 pequenos cortes realizados no abdome;
- **Laparotomia** – cirurgia realizada pelo abdome semelhante a cesárea;
- **Peri umbilical** – após parto vaginal, entre 24h e no máximo 48h, respeitando a *Golden hour* e a involução uterina pois neste período a altura uterina estará adequada para a realização do procedimento;
- **Vaginal** – cirurgia realizada pela vagina;
- **Peri-cesárea** – laqueadura tubária realizada oportunamente durante a cesariana no momento da cesárea previamente indicada por motivo obstétrico.

2. Entendo também que a realização de cesariana com intuito de realização de esterilização feminina continua sendo proibida por lei;

3. Qualquer cirurgia que venha a ser escolhida necessita de anestesia. O tipo de anestesia será avaliado e escolhido pelo Serviço de Anestesia;

4. Fui orientada de que a laqueadura tubária não é um método 100% eficaz. Existe uma porcentagem de falha de 0,41% que independe do paciente ou do médico;

5. Como em toda intervenção cirúrgica, existe um risco de mortalidade derivado do ato cirúrgico e da situação vital de cada paciente;

6. A reversão desta cirurgia, ou seja, a recanalização das tubas uterinas, tem limitada taxa de sucesso reprodutivo, não é disponibilizada nos serviços do SUS e não deve ser considerada como uma possibilidade no momento da decisão pelo método contraceptivo definitivo. Em caso de dúvidas ou considerando haver chance de arrependimento, opte por um método contraceptivo seguro e efetivo, mas não definitivo;

7. Assim como outros procedimentos cirúrgicos complicações que poderão surgir da laqueadura tubária, são: Intra-operatórias (hemorragias, lesões de órgãos), queimaduras por bisturi elétrico; Pós-operatórias leves e mais frequentes (seromas, hemorragias, cistites, anemia e outras); Pós-operatórias graves e menos comuns (evisceração, apneia, trombozes, hematomas, pelviperitonites, hemorragia e perfuração de órgãos);

8. Se no momento do ato cirúrgico surgir algum imprevisto, a equipe médica poderá variar a técnica cirúrgica programada;

9. O procedimento planejado da esterilização cirúrgica durante o período de parto (após passado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da minha vontade e o parto) poderá sofrer mudanças de técnica ou ser postergado, devido a condições médicas, técnicas ou de estrutura assistencial da maternidade;

10. Caso surjam contraindicações que impossibilitem realizar a laqueadura, entendo que a justificativa será registrada em prontuário e a equipe médica me orientará outro método para evitar gravidez;

11. Existem outros métodos de contracepção que não são irreversíveis como os métodos de barreira, anticoncepção hormonal e dispositivos intrauterinos;

12. Tenho ciência, conforme disposto na Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que a esterilização será objeto de notificação à direção do Sistema Único de Saúde. Entendi as explicações que me foram prestadas, em linguagem clara e simples, esclarecendo-me todas as dúvidas que me ocorreram. Também entendi que, a qualquer momento, antes que o procedimento de laqueadura tubária se realize e sem necessidade de dar nenhuma explicação, poderei revogar o consentimento que agora presto.

Assim, declaro que estou satisfeita com as informações recebidas e que compreendo o alcance e os riscos do tratamento.



Consinto, portanto, ao (à) médico (a) a realizar o (s) procedimento(s) e permito que utilize seu julgamento técnico para que sejam alcançados os melhores resultados possíveis através dos recursos conhecidos na atualidade pela Medicina e disponíveis no local onde se realiza o(s) tratamento(s).

Fica instituído que o presente termo tem validade indeterminada, e que, diante do procedimento proposto, o paciente e/ou representante legal pode revogar este consentimento a qualquer momento de maneira formal, e negar a realização do tratamento a qualquer momento, sem prejuízo legal ou restrição ao acesso dos serviços de saúde ou tratamentos futuros.

Para que produza os efeitos legais, assino o presente termo em TRÊS vias com igual teor e validade, recebendo uma das cópias.

CONCORDÂNCIA DOS ENVOLVIDOS

Assinatura do (a) Paciente

Nome:

RG:

CPF:

Assinatura do (a) Paciente

Nome:

RG:

CPF:

Joinville (SC): ____ de ____ de _____. Hora: ____:____.

Deve ser preenchido pelo médico assistente

Expliquei todo o tratamento a que o paciente acima referido deverá ser submetido, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre benefícios e riscos, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado, e o mesmo concorda em realizá-lo.

Nome do médico: _____. CRM/SC: _____.

Assinatura e Carimbo do Médico responsável pela aplicação do Termo de consentimento

Joinville (SC): ____ de ____ de _____. Hora: ____: ____.

RESOLUÇÃO CFM Nº 2.217/2018

“É vedado ao médico:

Art. 22 – Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte [...]

Art. 24 – Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo [...]

Art. 31 – Desrespeitar o direito do paciente ou seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte [...]

Art. 34 – Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar danos, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal.”

Lei 8.078 de 11/09/1990

Código Brasileiro de Defesa do Consumidor:

Art. 9º - O fornecedor de produtos ou serviços potencialmente perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

Art. 39º - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços dentre outras práticas abusivas: VI – executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes.



ANEXO 03

Esterilização Cirúrgica Voluntária e Eletiva

Conferência de Documentação Obrigatória

Documentos apresentados ao enfermeiro da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) e anexados ao processo:

- () Declaração de participação da orientação de Planejamento Reprodutivo (grupo ou consulta de enfermagem);
- () Declaração médica da UBSF quanto a aptidão do (a) usuário (a);
- () Comprovante de residência (cópia anexa);
- () Documento oficial com foto e CPF (cópia anexa com foto visível);
- () Certidão de Nascimento dos filhos (cópia anexa);
- () Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do requerente (cópia anexa);
- () Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado.

Assinatura e carimbo do (a) Enfermeiro (a) responsável

Joinville, ____ de _____ de _____



ANEXO 04

Esterilização Cirúrgica Eletiva

Processo para Esterilização Cirúrgica Voluntária e Eletiva destina-se para:

- () Masculina – Vasectomia
- () Feminina – Laqueadura Tubária

Unidade Básica de Saúde da Família solicitante: _____

Declaração

Declaro que _____,
CPF _____, participou de orientação no dia ____ / ____ / _____,
e teve acesso às **informações sobre todos os métodos reversíveis e irreversíveis de contracepção e esterilização** no Programa de Planejamento Reprodutivo, optando pelo procedimento de esterilização cirúrgica que é **considerado irreversível**. Possui ao menos um dos critérios abaixo:

- () Possui comprovadamente ____anos (mais de 21 anos);
- () Possui comprovadamente ____filhos (mínimo 2 filhos vivos).

Carimbo e assinatura Enfermeiro (a) -Coren/SC.

ANEXO 06

Esterilização Cirúrgica Eletiva – Laqueadura Tubária

Declaração Médica

Declaro que a usuária _____,
CPF _____ realizou no dia ____/____/____, avaliação
clínica e não foi detectada: Infecção local, sistêmica ou Sexualmente Transmissível
(IST), bem a como indicação do procedimento por Risco a vida, caso haja uma nova
gestação, ou condição de vulnerabilidade social, portanto dou o seguinte parecer:

- () Parecer **NÃO FAVORÁVEL** à indicação da usuária à Esterilização Cirúrgica Definitiva.
- () Parecer **FAVORÁVEL** à indicação da usuária à Esterilização Cirúrgica Definitiva
(deverá realizar avaliação pré-cirúrgica), mediante livre consentimento, .

Carimbo e assinatura do(a) Médico(a) - CRM/SC.



ORIENTAÇÕES PÓS LAQUEADURA TUBÁRIA

PACIENTE:

LAQUEADURA TUBÁRIA

1 - DORES NO PÓS-OPERATÓRIO SÃO COMUNS. USE AS MEDICAÇÕES PRESCRITAS E TENHA CUIDADO PARA MANTER O HÁBITO INTESTINAL SAUDÁVEL. INTESTINO PRESO É UMA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE DOR NO PÓS-OPERATÓRIO. CASO A DOR SEJA EXAGERADA PROCURAR O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL BETHESDA;

2 - SANGRAMENTOS PELA FERIDA OPERATÓRIA TAMBÉM SÃO COMUNS ATÉ CICATRIZAÇÃO. CASO HAJA SANGRAMENTO EXAGERADO DEVE-SE PROCURAR O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL BETHESDA;

3 - BEBA MUITO LÍQUIDO, EVITE INGESTÃO DE AÇÚCAR, FARINHA BRANCA E MUITOS DERIVADOS DO LEITE PARA MANTER HÁBITO INTESTINAL E URINÁRIO NORMAL;

4 - FEBRE OU SECREÇÃO PURULENTA PELA FERIDA OPERATÓRIA OU VAGINA NÃO SÃO SINTOMAS NORMAIS. PROCURE O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL BETHESDA;

5 - VOCÊ ESTÁ AUTORIZADA A FAZER PEQUENOS ESFORÇOS, PODE TOMAR O PRÓPRIO BANHO, SE ALIMENTAR SOZINHA OU MESMO SUBIR PEQUENOS LANCES DE ESCADA E FAZER PEQUENAS CAMINHADAS. ESFORÇOS INTENSOS E RELAÇÕES SEXUAIS SERÃO LIBERADOS EM 30 DIAS OU APÓS SEU RETORNO;

6 - SE CERTIFIQUE DE QUE SUA BIÓPSIA JÁ ESTÁ DISPONÍVEL E RETIRE JUNTO AO HOSPITAL BETHESDA. ELA É SUA COMPROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO;

7 - CASO HAJA NECESSIDADE O MÉDICO OU ENFERMEIRO DA UNIDADE BÁSICA PODEM ENCAMINHÁ-LA AO BETHESDA PARA RETORNO PÓS-OPERATÓRIO;

8 - OS PONTOS NÃO PRECISAM SER RETIRADOS.

BOA RECUPERAÇÃO.
OBRIGADA POR SUA CONFIANÇA.

HOSPITAL BETHESDA - R. Conselheiro Pedreira, 624 - Pirabeiraba, Joinville - SC, CEP 89239-200.